

1. La TVP est toujours définie comme une thrombose complète du réseau veineux profond des MI.	1. Faux
2. La TVP distale est limitée à l'étage poplité.	2. Faux
3. La TVP proximale affecte uniquement le réseau veineux superficiel.	3. Faux
4. La TVP est souvent associée à l'embolie pulmonaire.	4. Vrai
5. Environ 40-60% des patients atteints de TVP proximale ont une embolie pulmonaire symptomatique.	5. Faux
6. L'incidence de la TVP dans la population générale est d'environ 1 cas par 1000 par an.	6. Vrai
7. Les facteurs de risque de TVP sont tous réversibles.	7. Faux
8. La connaissance des facteurs de risque n'est pas nécessaire pour estimer la probabilité clinique de TVP.	8. Faux
9. Le score de Wells est un outil utilisé pour estimer la probabilité clinique de TVP.	9. Vrai
10. Un score de Wells élevé indique une probabilité clinique faible de TVP.	10. Faux
11. Le dosage des D-dimères est un test spécifique pour diagnostiquer la TVP.	11. Faux
12. Un résultat normal de D-dimères est utilisé pour exclure une TVP quand le score de Wells vaut 2.	12. Faux
13. L'échographie-Doppler des membres inférieurs est l'examen de premier choix pour diagnostiquer la TVP.	13. Vrai

14. L'échographie-Doppler est partiellement dépendante de l'opérateur.	14. Vrai
15. La thrombose veineuse superficielle est souvent asymptomatique.	15. Faux
16. La phlegmatia alba dolens est une présentation classique de TVP.	16. Vrai
17. La thrombose veineuse profonde n'entraîne jamais de dilatation des veines superficielles.	17. Faux
18. La thrombose veineuse profonde peut entraîner un syndrome post-thrombotique.	18. Vrai
19. Le score de Wells simplifié comporte 3 niveaux d'estimation de la probabilité clinique de TVP.	19. Faux
20. Un cancer actif confère un point dans le score de Wells simplifié.	20. Vrai
21. L'échographie-Doppler est moins sensible que le dosage des D-dimères pour détecter la TVP proximale.	21. Faux
22. La phlegmatia caerulea dolens nécessite un traitement urgent.	22. Vrai
23. Le syndrome post-thrombotique une insuffisance veineuse sévère avec dilatations veineuse superficielles, lourdeur de jambes, crampes, œdème, troubles trophiques, ulcères veineux, dermite ocre, hypodermite,...	23. Vrai
24. Le dosage des D-dimères est recommandé uniquement lorsque le score de Wells est égal ou supérieur à 2.	24. Faux
25. Les patients âgés ont généralement des résultats de D-dimères faussement positifs.	25. Vrai
26. Le traitement anticoagulant est toujours nécessaire en cas de TVP confirmée.	26. Vrai
27. La TVP distale est souvent plus grave que la TVP proximale.	27. Faux

28. La TVP est plus fréquente chez les femmes enceintes ou en post-partum.	28. Vrai
29. Les traumatismes ou les chirurgies récentes sont des facteurs de risque réversibles de TVP.	29. Vrai
30. Les longs voyages en avion n'augmentent pas le risque de TVP.	30. Faux
31. Le syndrome de Cockett est un facteur de risque non réversible de TVP.	31. Faux
32. Les antécédents de TVP sont un facteur de risque réversible de TVP.	32. Faux
33. La thrombose veineuse superficielle est toujours une complication de la thrombose veineuse profonde.	33. Faux
34. L'érythème franc de l'érysipèle est souvent confondu avec l'érythrocyanose décline de la TVP.	34. Vrai
35. La TVP est souvent asymptomatique.	35. Faux
36. 50 à 70% des patients atteints d'embolie pulmonaire ont une TVP.	36. Vrai
37. Les varices sont un facteur de risque réversible de TVP.	37. Faux
38. Le syndrome post-thrombotique se caractérise par des crampes et un œdème des membres inférieurs.	38. Vrai
39. Les D-dimères sont un test spécifique pour diagnostiquer la TVP.	39. Faux
40. L'échographie-Doppler est très sensible (>95%) pour diagnostiquer une TVP distale.	40. Faux
41. Le syndrome post-thrombotique se caractérise par des veines superficielles dilatées et un érythème.	41. Faux
42. Les embolies pulmonaires sont plus fréquentes que les TVP.	42. Faux

43. Les moyens thérapeutiques utilisés pour traiter la TVP incluent uniquement l'anticoagulation.	43. Faux
44. La fibrinolyse est un moyen thérapeutique couramment utilisé pour traiter la TVP.	44. Faux
45. Les indications de la chirurgie dans le traitement de la TVP sont très limitées.	45. Vrai
46. Une TVP située sous le genou est considérée comme distale.	46. Vrai
47. Les facteurs de risque de récurrence de la TVP distale comprennent le cancer actif et l'âge > 50 ans.	47. Vrai
48. La mobilisation est recommandée avant le début du traitement anticoagulant pour la TVP proximale.	48. Faux
49. La TVP distale nécessite uniquement une anticoagulation de 3 mois si le risque de récurrence est faible.	49. Faux
50. La thérapie compressive immédiate (<24h) fait partie intégrante du traitement de la TVP proximale.	50. Vrai
51. La compression recommandée en cas de TVP proximale comprend uniquement des bandages adhésifs.	51. Faux
52. L'anticoagulation est recommandée pendant au moins 6 mois pour les patients présentant une TVP proximale isolée et un risque intermédiaire de récurrence.	52. Faux
53. Les anticoagulants oraux directs ne nécessitent pas de contrôle sanguin ni d'ajustement de la dose.	53. Vrai
54. Le dosage des D-dimères est utile uniquement pour exclure une TVP si un autre test très sensible est normal.	54. Vrai
55. La contention et la mobilisation font partie du traitement de la TVP distale.	55. Faux
56. L'interruption partielle de la veine cave inférieure est recommandée pour tous les patients atteints de TVP.	56. Faux

57. Le traitement chirurgical est souvent nécessaire pour traiter la TVP.	57. Faux
58. Le syndrome post-thrombotique survient 6 mois à 2 ans après une TVP.	58. Vrai
59. Le diagnostic du syndrome post-thrombotique dépend principalement de l'imagerie médicale.	59. Faux
60. La thrombose de la veine cave inférieure entraîne généralement des symptômes unilatéraux.	60. Faux
61. La TVP des membres supérieurs peut être causée par une compression extrinsèque par une tumeur.	61. Vrai
62. La thrombose veineuse jugulaire est toujours associée à une thrombophilie.	62. Faux
63. La thrombose veineuse jugulaire se manifeste par des douleurs cervicales et un gonflement.	63. Vrai
64. Le traitement anticoagulant est nécessaire pour éviter l'extension de la TVP et prévenir les récives..	64. Vrai
65. Les anticoagulants directs sont éliminés essentiellement par voie rénale.	65. Vrai
66. La thrombolyse est recommandée comme traitement de première intention pour la TVP.	66. Faux
67. Le syndrome post-thrombotique peut survenir jusqu'à 5 ans après une TVP.	67. Faux
68. La thrombose de la veine cave inférieure est rarement liée à une origine néoplasique.	68. Vrai
69. La TVP des membres supérieurs est toujours causée par des cathéters.	69. Faux
70. Le traitement anticoagulant est recommandé uniquement pour les TVP proximales.	70. Faux
71. Les anticoagulants directs présentent un risque d'interaction médicamenteuse.	71. Vrai

72. Le traitement anticoagulant est recommandé pour tous les types de TVP.	72. Vrai
73. La thrombose de la veine cave inférieure est le plus souvent causée par l'extension d'un thrombus iliaque.	73. Vrai
74. La thrombose veineuse superficielle peut être causée par un cathétérisme veineux.	74. Vrai
75. Dans 75% des cas, la thrombose veineuse superficielle survient sur des varices.	75. Vrai
76. La thrombophlébite ne survient jamais sur une veine saine.	76. Faux
77. La TVS est associée à une douleur sur le trajet veineux qui prend un aspect bleu et induré.	77. Faux
78. L'hyperthermie locale est un signe courant dans la thrombose veineuse superficielle.	78. Vrai
79. L'échographie-Doppler est utile pour évaluer l'extension d'une thrombose veineuse superficielle.	79. Vrai
80. La thrombose veineuse superficielle peut parfois s'étendre au réseau profond via les veines perforantes.	80. Vrai
81. Le traitement de la thrombose veineuse superficielle comprend l'utilisation d'anti-inflammatoires stéroïdiens.	81. Faux
82. La contention et la mobilisation ne sont pas essentielles dans le traitement de la TVS.	82. Faux
83. Le traitement anticoagulant n'est jamais utilisé dans la thrombose veineuse superficielle.	83. Faux
84. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés pour traiter les symptômes de la TVS.	84. Vrai
85. Le traitement anticoagulant est souvent proposé pour prévenir l'extension de la thrombose veineuse superficielle étendue à proximité de la jonction saphéno-fémorale.	85. Vrai

86. La thrombose veineuse superficielle est toujours associée à des varices.	86. Faux
87. La TVS est définie comme une thrombose partielle ou complète du réseau veineux profond des MI.	87. Faux
88. Une thrombose du réseau veineux profond poplité est considérée comme une TVP distale.	88. Faux
89. Les thromboses distales sont limitées à l'étage sous-poplité.	89. Vrai
90. Le TVP proximales peuvent toucher les veines fémorales, la veine iliaque ou la veine cave inférieure.	90. Vrai
91. La TVP est très fréquemment associée à l'embolie pulmonaire.	91. Vrai
92. 40 à 60% des cas de TVP proximale symptomatique ont une embolie pulmonaire asymptomatique.	92. Vrai
93. La maladie thrombo-embolique veineuse désigne uniquement les thromboses veineuses profondes.	93. Faux
94. Tous les patients atteints d'embolie pulmonaire ont une TVP.	94. Faux
95. La maladie thromboembolique veineuse est l'affection cardiovasculaire la plus fréquente après les maladies coronariennes et les AVC.	95. Vrai
96. L'incidence de l'embolie pulmonaire dans la population générale est de 0,5/1000 par an.	96. Vrai
97. La triade de Virchow regroupe les 3 facteurs favorisant les thromboses veineuses.	97. Vrai
98. La présence de facteurs de risque de TVP ne modifie pas la durée du traitement.	98. Faux
99. Les anomalies du flux sanguin comme la stase veineuse ou le flux rétrograde prédisposent à la TVP.	99. Vrai

100. Les lésions de la paroi des vaisseaux prédisposent à la TVP.	100. Vrai
101. La composition chimique du sang ne modifie pas le risque de TVP.	101. Faux
102. Les contraceptifs oraux et l'hormonothérapie sont des facteurs de risque réversibles de TVP.	102. Vrai
103. L'obésité est considéré comme un facteur de risque non réversible de TVP.	103. Vrai
104. Les anomalies de l'hémostase doivent être recherchées en cas de TVP : facteur V Leiden, excès en protéines C ou S, anomalies de la fibrinolyse, facteurs VIII, IX ou XI élevés, déficit en anti-thrombine,...	104. Faux
105. Une mutation dans le gène de la prothrombine ou une hypohomocystéinémie peuvent induire des TVP.	105. Faux
106. Une dysplasminogénie/dysfibrinogénémie ou des anticorps antiphospholipides peuvent induire des TVP.	106. Vrai
107. La triade de Virchow associe stase veineuse, lésions pariétales et anomalies de l'hémostase.	107. Vrai
108. Cancer, désordres myéloprolifératifs, inflammation (Crohn, RCUH, Behçet,...) et syndrome néphrotique sont des causes d'anomalies de l'hémostase.	108. Vrai
109. L'âge n'est pas en soi un facteur de risque de thrombose veineuse profonde.	109. Faux
110. Le risque de récurrence est d'autant plus grand que la TVP survient après une immobilisation courte.	110. Vrai
111. La phlegmatia caerulea dolens est la présentation la plus classique de TVP.	111. Faux
112. Le signe de Homans correspond à une douleur spontanée ou provoquée du mollet en cas de TVP.	112. Vrai

113. La phlegmatia alba dolens se manifeste par un œdème bilatéral, une douleur du mollet, une dilatation des veines superficielles, une hyperthermie cutanée locale et une érythrocyanose déclive.	113. Faux
114. Le TVP ne provoque jamais un œdème de tout le membre inférieur.	114. Faux
115. L'œdème est le plus souvent unilatéral ou asymétrique en cas de TVP.	115. Vrai
116. La TVP peut parfois provoquer une douleur à l'aîne ou sur la face externe de la cuisse (trajet veineux).	116. Faux
117. L'hyperthermie cutanée locale est parfois le seul signe de TVP.	117. Vrai
118. L'arrêt du retour veineux profond en cas de TVP entraîne une dilatation du réseau veineux superficiel et une coloration cyanique diffuse du membre inférieur en amont de l'occlusion.	118. Vrai
119. La TVP peut entraîner une érythrocyanose en position couchée.	119. Faux
120. L'érythème franc de l'érysipèle fait partie du diagnostic différentiel de la phlegmatia carulea dolens.	120. Faux
121. La phlébite bleue se manifeste par un tableau d'ischémie aigue associée aux signes cliniques de TVP.	121. Vrai
122. Le syndrome post-thrombotique est la complication majeure de la TVP.	122. Faux
123. La TVP ne provoque jamais de signes inflammatoires.	123. Faux
124. La phlébite bleue correspond à une TVP distale extensive provoquant une stagnation veineuse aigue et un blocage de l'apport artériel.	124. Faux

125. Les ulcères siègent souvent dans la région sus-malléolaires en cas de syndrome post-thrombotique.	125. Vrai
126. La phlegmatia alba dolens est caractérisée par un arrêt de l'apport artériel et une ischémie aigue du MI.	126. Faux
127. Un antécédent de cancer dans les 6 mois précédent confère un point dans le score de Wells simplifié.	127. Vrai
128. Un gonflement du mollet est à déterminer au niveau de la tubérosité tibiale.	128. Faux
129. Un alitement récent de 2 jours confère un point dans le score de Wells simplifié.	129. Faux
130. La TVP est probable si le score de Wells simplifié vaut 0 ou 1.	130. Faux
131. Il faut soustraire un point au score de Wells simplifié si un diagnostic différentiel au moins aussi probable que la TVP est présent.	131. Faux
132. Une douleur localisée sur un trajet veineux profond confère un point dans le score de Wells simplifié.	132. Vrai
133. Une chirurgie majeure au cours des 4 dernières semaines confère un point dans le score de Wells simplifié.	133. Vrai
134. Les antécédents de TVP ne sont pas pris en compte dans le score de Wells simplifié.	134. Faux
135. Un gonflement généralisé du membre inférieur ou un gonflement du mollet >3cm confèrent un point dans le score de Wells simplifié.	135. Vrai
136. Les varices ne sont pas prises en compte dans le score de Wells simplifié.	136. Vrai
137. Un œdème prenant le godet confère un point dans le score de Wells simplifié.	137. Vrai

138. Les veines superficielles collatérales confèrent un point dans le score de Wells simplifié.	138. Vrai
139. Une paralysie, une parésie ou une immobilisation plâtrée des membres inférieurs confère 2 points dans le score de Wells simplifié.	139. Faux
140. Les performances diagnostiques du dosage des D-dimères dépend fortement du test utilisé.	140. Vrai
141. Le dosage des D-dimères a une bonne sensibilité et une bonne spécificité pour la TVP.	141. Faux
142. L'âge avancé, un syndrome inflammatoire, un cancer, un traumatisme ou une situation post-opératoire peuvent positiver le dosage des D-dimères en l'absence de TVP.	142. Vrai
143. Le dosage des D-dimères est utile pour confirmer le diagnostic de TVP.	143. Faux
144. Les anticoagulants oraux directs peuvent être utilisés sans pré-traitement par HBPM dans tous les cas.	144. Faux
145. Le dosage des D-dimères est nécessaire quand le score de Wells simplifié vaut 0 ou 1.	145. Vrai
146. Une TVP peut être raisonnablement exclue si le score de Wells vaut 1 et si les D-dimères sont normaux.	146. Vrai
147. Une augmentation des D-dimères est une indication à l'échographie veineuse des membres inférieurs même en cas de TVP peu probable.	147. Vrai
148. Le dosage des D-dimères est nécessaire si le score de Wells vaut 2 ou plus.	148. Faux
149. L'échographie veineuse des membres inférieurs est systématiquement réalisé en cas de TVP probable.	149. Vrai

150.	L'écho-Doppler des membres inférieurs à une excellente sensibilité et spécificité pour les TVP proximales.	150. Vrai
151.	Le traitement des TVP vise à prévenir les embolies pulmonaires et le syndrome post-thrombotique.	151. Vrai
152.	Le traitement des TVP comprend essentiellement une anticoagulation et une contention veineuse.	152. Vrai
153.	Le traitement des TVP ne permet pas d'améliorer les symptômes.	153. Faux
154.	Par définition, une TVP située sous le genou est une TVP proximale.	154. Faux
155.	Les TVP proximales à faible risque de récurrence nécessitent juste une courte anticoagulation par HBPM.	155. Faux
156.	Les TVP distales à faible risque de récurrence nécessitent une surveillance échographique.	156. Vrai
157.	Les TVP affectant la trifurcation poplitée et/ou plus d'une veine du mollet sont à risque élevé de récurrence.	157. Vrai
158.	Le sexe féminin est un facteur de risque élevé de récurrence de TVP distale.	158. Faux
159.	Les TVP bilatérales sont à risque élevé de récurrence.	159. Vrai
160.	Les TVP distales à risque de récurrence élevé nécessite uniquement une anticoagulation pendant 3 mois.	160. Vrai
161.	Les TVP distales à risque de récurrence faible nécessite une anticoagulation par héparine non fractionnée.	161. Faux
162.	Les TPV distales idiopathiques sont à faible risque de récurrence.	162. Faux
163.	Toutes les TVP proximales doivent être recevoir une anticoagulation pendant au moins 3 mois.	163. Vrai
164.	Le syndrome post-thrombotique est causée par l'absence de dissolution complète des thrombus veineux.	164. Vrai

165. La thérapie compressive immédiate doit être débutée dans les 12 heures après une TVP proximale.	165. Faux
166. La thérapie compressive immédiate contribue à la régression des symptômes.	166. Vrai
167. La thérapie compressive immédiate ne réduit pas l'incidence du syndrome post-thrombotique.	167. Faux
168. La thérapie compressive utilise des bandages adhésifs en cas d'œdème important suite à une TVP.	168. Vrai
169. Les bas de prévention de la thrombose exercent une pression de 15-18mmHg au niveau de la cheville.	169. Vrai
170. Les bas de maintien sans règlementation exercent généralement une pression de 10mmHg.	170. Faux
171. Les bas de maintien sans règlementation ont généralement un nombre de deniers entre 30 et 50.	171. Faux
172. Les bas de compression médicaux de classe III (forte) exercent une pression de 23-32mmHg.	172. Faux
173. Les bas de compression médicaux de classe IV (très forte) exercent une pression de >49mmHg.	173. Vrai
174. Les bas de compression médicaux de classe A exercent une pression de 15-21mmHg.	174. Faux
175. Les bas de compression médicaux de classe II (moyenne) exercent une pression de 34-46mmHg.	175. Faux
176. La mobilisation est recommandé dès que le patient est correctement anti-coagulé après une TVP.	176. Vrai
177. Toutes les TVP distales doivent être recevoir une anticoagulation pendant au moins 3 mois.	177. Faux
178. Les TVPs proximales survenant après une chirurgie sous anesthésie générale de >30min sont à faible risque de récidence.	178. Vrai

179. Les TVPs proximales survenant après un alitement de <3 jours sont à faible risque de récurrence.	179. Faux
180. Les TVPs proximales survenant après un traumatisme avec fracture sont à faible risque de récurrence.	180. Vrai
181. L'anticoagulation peut être stoppée après 6 mois en cas de TVP proximale à faible risque de récurrence.	181. Faux
182. Les TVPs proximales survenant après une chirurgie mineure sont à risque intermédiaire de récurrence.	182. Vrai
183. Les TVPs proximales survenant après un vol long-courrier sont à faible risque de récurrence.	183. Faux
184. Les TVPs proximales survenant lors de la grossesse ou en péri-partum sont à risque élevé de récurrence.	184. Faux
185. Les TVPs proximales chez le patient obèse sont à risque intermédiaire de récurrence.	185. Vrai
186. Les TVPs proximales après une anesthésie générale de >30min sont à risque intermédiaire de récurrence.	186. Faux
187. Les TVPs proximales chez le patient atteint de maladies inflammatoires de l'intestin ou de maladies auto-immunes persistantes et actives sont à risque intermédiaire de récurrence.	187. Vrai
188. Les TVPs proximales avec poursuite du traitement oestrogénique sont à risque élevé de récurrence.	188. Faux
189. Les TVPs distales survenant après une blessure à la jambe sans fracture associée à une mobilité réduite pendant au moins 3 jours sont à risque intermédiaire de récurrence.	189. Faux
190. Les TVPs proximales chez les patients avec un cancer actif sont à risque élevé de récurrence.	190. Vrai
191. Les TVPs proximales avec un syndrome des anticorps phospholipides sont à risque élevé de récurrence.	191. Vrai

192. L'anticoagulation doit être poursuivie pendant >3 mois pour les TVP proximales à risque élevé de récurrence.	192. Vrai
193. Il faut toujours envisager de poursuivre l'anticoagulation >3 mois pour les TVP proximales à risque intermédiaire de récurrence.	193. Faux
194. Les TVPs proximales avec une thrombophilie héréditaire majeure sont à risque intermédiaire de récurrence.	194. Faux
195. La dose du traitement anticoagulant peut éventuellement être abaissée après 3 mois pour les TVP proximales à risque intermédiaire de récurrence.	195. Vrai
196. Les patients avec des antécédents familiaux importants de TVP sont à risque élevé de récurrence.	196. Vrai
197. Le dabigatran est un inhibiteur du facteur de coagulation Xa.	197. Faux
198. Contrairement aux AVK, les AOD sont actifs d'emblée par voie orale.	198. Vrai
199. L'apixaban, l'édoxaban et le rivaroxaban sont des inhibiteurs de la thrombine.	199. Faux
200. Certains ADO et les AVK nécessitent un pré-traitement par HBPM pendant 5 à 10 jours en cas de TVP.	200. Vrai
201. Les HBPM sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère (clearance de créatinine <30ml/min).	201. Vrai
202. L'héparine non fractionnée est administrée en intra-musculaire.	202. Faux
203. Le taux de plaquettes doit être surveillé toutes les 6 heures lors du pré-traitement anticoagulant.	203. Faux
204. Un allongement de l'APTT permet de vérifier l'activité anticoagulante lors du traitement par héparine.	204. Vrai

205.	L'activité anticoagulante doit être vérifiée toutes les 6h lors du pré-traitement anticoagulant.	205. Vrai
206.	Les AVKs doivent être administrés le même jour ou le lendemain du début du traitement héparinique.	206. Vrai
207.	L'INR doit être compris entre 2,5 et 3,5 dans le traitement d'une TVP proximale par AVK.	207. Faux
208.	Le traitement de la TVP par des AVK doit toujours être précédé d'un pré-traitement par héparine.	208. Vrai
209.	Le traitement de la TVP par apixaban doit toujours être précédé d'un pré-traitement par héparine.	209. Faux
210.	Le traitement héparinique doit être maintenu à doses thérapeutiques jusqu'à l'obtention d'un INR <2.	210. Faux
211.	La dose d'AVK est adaptée selon le contrôle quotidien de l'INR de J3 à J5.	211. Vrai
212.	Contrairement aux anticoagulants directs, les AVK sont actifs d'emblée par voie orale.	212. Faux
213.	Les anticoagulants directs sont généralement préférés aux AVK dans le traitement de la TVP.	213. Vrai
214.	L'héparine de bas poids moléculaire doit être administrée en perfusion IV continue.	214. Faux
215.	La chirurgie, la thrombolyse et l'interruption partielle de la VCI sont des traitement exceptionnels de TVP.	215. Vrai
216.	La thrombolyse utilise des schémas à base de streptokinase et d'urokinase.	216. Vrai
217.	La thrombolyse permet de réduire efficacement l'incidence du syndrome post-thrombotique.	217. Faux
218.	La thrombolyse augmente de 2x le risque d'hémorragies majeures par rapport à l'héparine.	218. Faux
219.	La thrombolyse est réservée aux patients jeunes avec une TVP extensive (phlébite bleue) et sans CI.	219. Vrai

220. Le traitement thrombolytique permet de se passer de la contention et de la mobilisation.	220. Faux
221. L'interruption partielle de la VCI vise à empêcher la migration d'embolies vers les artères pulmonaires.	221. Vrai
222. L'interruption partielle de la VCI est réalisée par l'insertion chirurgicale d'un filtre dans la veine.	222. Faux
223. Les « caillots flottants » sont une indication d'interruption partielle de la VCI en urgence.	223. Faux
224. L'interruption partielle de la VCI est utilisée en cas de coexistence de TVP et d'embolie pulmonaire chez les patients qui présentent une contre-indication au traitement anticoagulant.	224. Vrai
225. Le filtre cave doit rapidement être retiré après une interruption partielle de la VCI.	225. Vrai
226. L'interruption partielle de la VCI n'est pas utilisée en cas de récurrences thromboemboliques en présence d'un traitement anticoagulant bien adapté.	226. Faux
227. L'anticoagulation doit être débutée dès la résolution de la CI même en présence d'un filtre cave.	227. Vrai
228. Le traitement chirurgical de la TVP est réalisé quand le membre est en danger en présence d'une contre-indication à la thrombolyse.	228. Vrai
229. Le syndrome post-thrombotique se développe dans les 4 mois suivants une TVP.	229. Faux
230. L'œdème du membre inférieur est d'emblée irréversible en cas de syndrome post-thrombotique.	230. Faux
231. Le syndrome post-thrombotique ne s'accompagne jamais de troubles trophiques.	231. Faux

232. Le syndrome post-thrombotique est lié à plusieurs facteurs : obstruction veineuse persistante, incontinence valvulaire, perte de la fonction veineuse, hypertension veineuse et microcirculatoire,...	232. Vrai
233. Le Doppler est inutile dans le diagnostic du syndrome post-thrombotique.	233. Faux
234. La thrombose veineuse des membres supérieurs donne une clinique similaire à une TVP.	234. Vrai
235. La thrombose veineuse des membres supérieurs peut parfois s'étendre à la veine cave supérieure.	235. Vrai
236. La TVS est très souvent d'origine iatrogène suite à un cathéterisme veineux.	236. Vrai
237. La TVS survient le plus souvent sur le trajet de la veine saphène externe.	237. Faux
238. Une thrombophlébite sur une veine saine doit faire suspecter une néoplasie ou une maladie de Buerger.	238. Vrai
239. La maladie de Behçet est associée aux TVP mais pas aux TVS.	239. Faux
240. Une pathologie auto-immunitaire, une pathologie hématologique ou une anomalie de l'hémostase peuvent provoquer des thrombophlébites sur une veine saine.	240. Vrai
241. La TVS entraîne une hyperthermie locale, une rougeur et une douleur sur un trajet veineux.	241. Vrai
242. La TVS a parfois un aspect « en battant de cloche » à la jonction entre la crosse de la saphène interne et de la veine fémorale superficielle.	242. Faux
243. Les AVK sont parfois utilisés dans le traitement des TVS étendues pros de la jonction saphéno-fémorale.	243. Faux